THORAX · TH-01

# Nodule pulmonaire fortuit · Fleischner

**Fleischner Society 2017**
scanner hors dépistage · adulte ≥ 35 ans

**Champ d'application :** nodule découvert fortuitement au scanner chez l'adulte **≥ 35 ans**. Non applicable au **dépistage** (voir TH-02), aux patients avec **cancer connu** ou **immunodéprimés**. Mesure : moyenne du grand et du petit axe sur la même coupe, arrondie au mm ; volumétrie possible.

## NODULE SOLIDE

| TAILLE | UNIQUE · BAS RISQUE | UNIQUE · HAUT RISQUE | MULTIPLES · BAS RISQUE | MULTIPLES · HAUT RISQUE |
|---|---|---|---|---|
| **< 6 mm** < 100 mm³ | Pas de suivi | Scanner à 12 mois optionnel | Pas de suivi | Scanner à 12 mois optionnel |
| **6–8 mm** 100–250 mm³ | Scanner à 6–12 mois, puis envisager à 18–24 mois | Scanner à 6–12 mois, puis à 18–24 mois | Scanner à 3–6 mois, puis envisager à 18–24 mois | Scanner à 3–6 mois, puis à 18–24 mois |
| **> 8 mm** > 250 mm³ | Envisager un scanner à 3 mois, une TEP-TDM ou un prélèvement | | Scanner à 3–6 mois, puis envisager à 18–24 mois | |

## NODULE SUBSOLIDE

| TYPE | < 6 MM | ≥ 6 MM |
|---|---|---|
| **Verre dépoli pur**, unique | Pas de suivi | Scanner à 6–12 mois ; si persistant, scanner tous les 2 ans jusqu'à 5 ans |
| **Partiellement solide**, unique | Pas de suivi | Scanner à 3–6 mois ; si persistant et composante solide < 6 mm, scanner annuel pendant 5 ans. **Composante solide ≥ 6 mm : très suspect** |
| **Multiples** | Scanner à 3–6 mois ; si stable, envisager à 2 et 4 ans | Scanner à 3–6 mois, puis selon le nodule le plus suspect |

## ESTIMER LE RISQUE

### Haut risque (> 5 %)

- Tabagisme important, âge avancé, exposition (amiante, radon, uranium), antécédent familial
- Contours spiculés, localisation lobaire supérieure
- Emphysème, fibrose
- Calculateurs utiles : Brock (PanCan), Mayo

### Aspects rassurants

- Calcifications bénignes (centrale, lamellaire, pop-corn, diffuse)
- Graisse intranodulaire (hamartome)
- **Nodule périscissural ou juxtapleural typique** (triangulaire, lentiforme, contours lisses, < 10 mm) : ganglion intrapulmonaire, pas de suivi
- Stabilité ≥ 2 ans pour un solide ; ≥ 5 ans pour un subsolide

## PIÈGES

**Coupes fines**
≤ 1,5 mm (idéalement 1 mm) pour caractériser et mesurer

**Croissance**
< 2 mm : peu fiable en mesure linéaire ; préférer la volumétrie sur le même logiciel

**Subsolide**
un nodule subsolide peut régresser (inflammatoire) : contrôle avant toute décision

**Contexte**
infection récente, jeune âge, cancer connu : ne pas appliquer ces règles

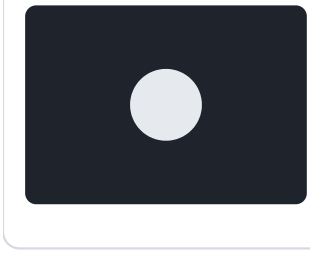
THORAX · TH-01

# Nodule pulmonaire fortuit · Fleischner (suite)

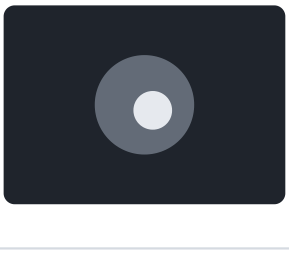
**Fleischner Society 2017**
scanner hors dépistage · adulte ≥ 35 ans

## ATLAS VISUEL

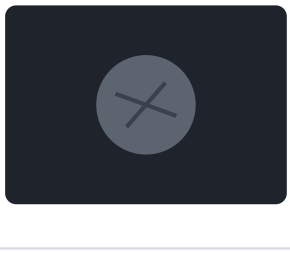
### Types de nodules et mesure



**Solide**
masque le parenchyme



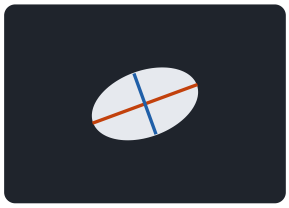
**Partiellement solide**
mesurer la composante solide



**Verre dépoli pur**
vaisseaux visibles au travers



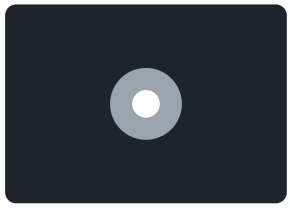
**Périscissural**
triangulaire, < 10 mm : bénin



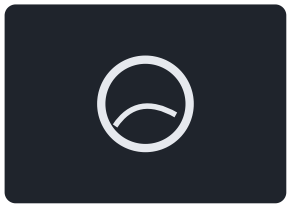
**Mesure**
(grand + petit axe) / 2



**Spiculé**
haut risque



**Calcification centrale**
bénin (granulome)



**Kyste atypique**
paroi épaisse ou cloisons (Lung-RADS)

Schémas simplifiés, non à l'échelle · fenêtre parenchymateuse

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Recommandations Fleischner**
Radiopaedia · tableaux
radiopaedia.org/articles/fleischner-society-pulm

**Nodule partiellement solide**
Radiopaedia · mesure, évolution
radiopaedia.org/articles/part-solid-lung-nodule-

**Nodule périscissural typique (cas)**
Radiopaedia · ganglion intrapulmonaire
radiopaedia.org/cases/typical-perifissural-nodul

**Nodule en verre dépoli pur**
Radiopaedia · conduite
radiopaedia.org/articles/pure-ground-glass-nodul

**Calculateur de Brock (PanCan)**
Brock University · risque de malignité
brocku.ca/lung-cancer-screening-and-risk-predict

**Sources :** MacMahon et al., Radiology 2017 – pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2017161659 · Radiopaedia – Fleischner 2017 – radiopaedia.org/articles/fleischner-society-pulmonary-nodule...